PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Exercício na gestação e no pós-parto

Um roteiro em seis passos

A Atleta Mulher

CATORZE SEMANAS DE GESTAÇÃO

Na gestação sem complicação, ficar parada não é a opção segura

“pode caminhar”

“só com liberação por escrito”



“é perigoso levantar peso”

“não levante o braço acima da cabeça”

> Seguir a recomendação: cerca de 40% [illegible] e pré-eclâmpsia; ao menos 25% menos depressão.

quatro semanas sem treino

Diretriz canadense, Br J Sports Med 2018

PASSO UM

Pergunte à obstetrícia de forma específica

“pode treinar?”

“agachamento moderado e corrida em ritmo de conversa, 3 vezes por semana, 30 minutos: liberado?”

não liberado ≠ contraindicado

a maioria das “não liberadas” nunca teve a pergunta feita

Contraindicações: decide a obstetrícia

- membranas rotas, trabalho de parto prematuro
- sangramento persistente sem explicação
- placenta prévia após 28 semanas
- pré-eclâmpsia, colo incompetente
- restrição de crescimento fetal
- doenças descontroladas

PASSO DOIS

A dose: 150 minutos, força incluída, assoalho pélvico todo dia

150
minutos por semana, moderado

3+
dias por semana

2
aeróbico e força, juntos

1×
assoalho pélvico, todo dia

já treinava: continua, com ajustes

sedentária: pode começar, com progressão

elite com volume e intensidade muito altos: menos dados, conversa obrigatória com a obstetrícia

Diretriz canadense, Br J Sports Med 2018

PASSO TRÊS

O corpo mudou: muda o guia, não a força

frequência de repouso sobe	→ guiar pelo teste da fala	centro de massa muda	→ evitar queda, não força
tontura deitada de costas	→ mudar de posição	calor e glicemia oscilam	→ ventilação e comer antes

Fica

treino de força, carga adequada, progressão

Sai

contato, queda, mergulho autônomo, Valsalva sustentada

PASSO QUATRO

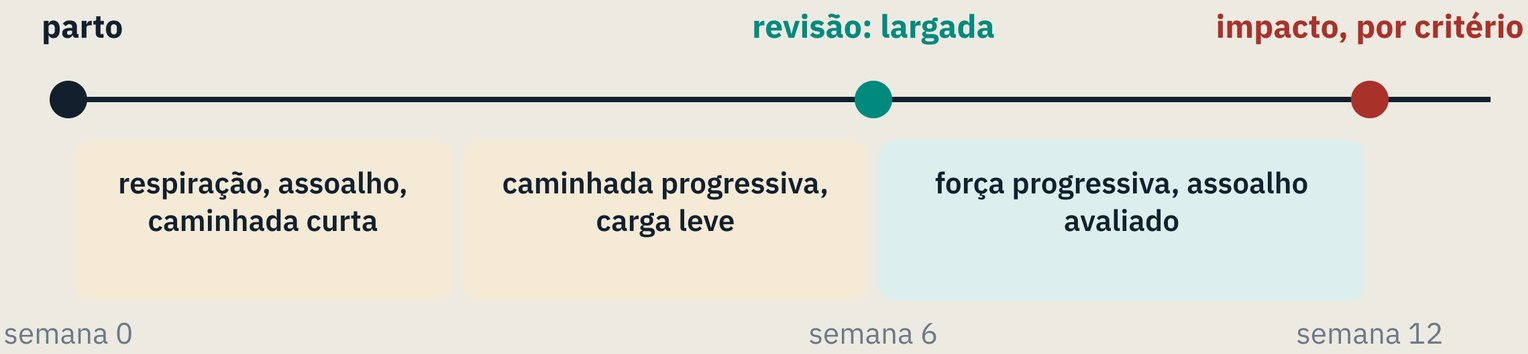
Dez sinais que qualquer um na sala precisa saber de cor

- sangramento vaginal
- perda de líquido
- dor abdominal persistente
- contrações regulares e dolorosas
- falta de ar antes do esforço
- tontura ou desmaio
- dor de cabeça
- dor no peito
- fraqueza com perda de equilíbrio
- dor ou inchaço na panturrilha

Qualquer um: parar e procurar a obstetrícia, sem esperar a próxima consulta

PASSO CINCO

Seis semanas é largada; o impacto vem por critério



cesárea: mais tempo antes de carga no abdome · esquema

Orientação britânica de retorno à corrida no pós-parto, 2019

Critérios para o impacto

- sem perda urinária no esforço
- sem peso ou pressão vaginal
- sem dor
- testes de impacto e força tolerados

não antes de três meses

PASSO SEIS

Três perguntas, a toda mulher que treina

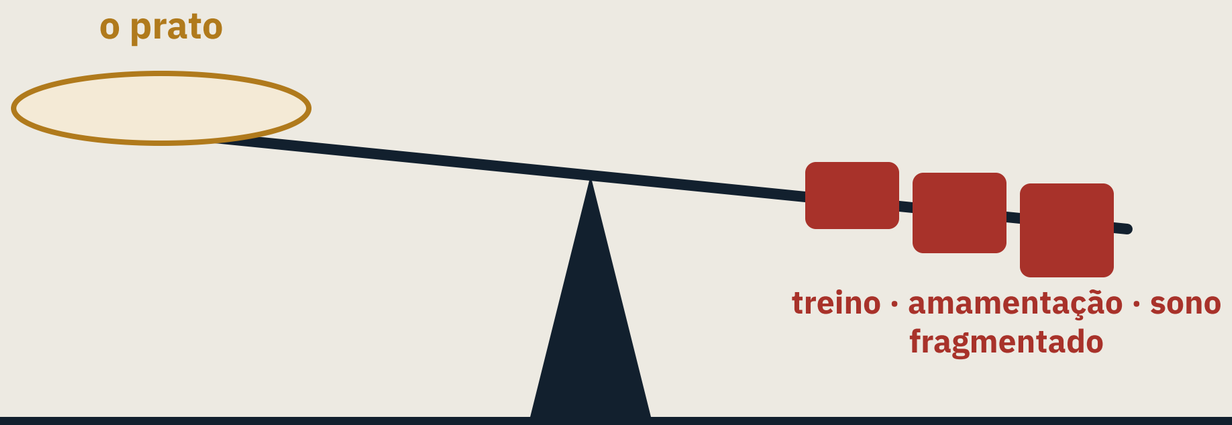
- Perde urina quando tosse, espirra, salta ou corre?
- Sente peso, pressão ou uma bola na vagina?
- Sente dor na relação?

→ qualquer sim → **fisioterapia pélvica**

⚠ **“faça Kegel” não é prescrição: muitas contraem o músculo errado**

⚠ **assoalho tenso, com dor: contrair mais piora**

No pós-parto, a deficiência energética perde o alarme habitual





O vértice do ciclo fica apagado por um motivo normal: osso, lesões e rendimento pesam mais

Parar não é neutro; voltar tem critério

- Gestação sem complicação: pergunta específica à obstetrícia e a dose prescrita
- Seis semanas é largada: impacto não antes de três meses, e só por critério
- Assoalho pélvico: três perguntas a toda mulher que treina; qualquer sim encaminha

Quem treina e prepara

Ajusta o treino, sabe os sinais para parar e leva a pergunta específica.

Fisioterapia pélvica

Avalia e trata o assoalho e define o critério para o impacto.

Obstetrícia

Decide as contraindicações e acompanha a gestação.